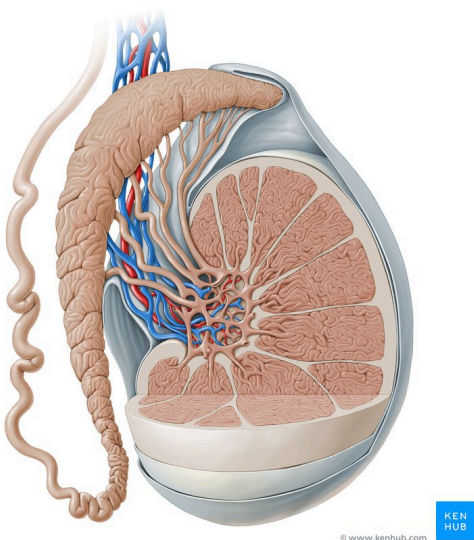




NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 semestre 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE: Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR REALIZAR: VASECTOMIA			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción) El objetivo quirúrgico de la vasectomía es lograr la esterilización masculina permanente mediante la interrupción y oclusión de los conductos deferentes, impidiendo el paso de los espermatozoides desde los testículos hacia el semen eyaculado. 1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción). ANATOMÍA  Los testículos son glándulas reproductoras masculinas localizadas en el escroto. Poseen forma ovoidea, con 4 a 6cm de longitud y con un peso de 10-15 gramos.			



El escroto es usualmente asimétrico, con un testículo más inferior que el otro (usualmente el izquierdo). Los testículos están suspendidos dentro del escroto por el cordón espermático.

Capas del testículo

- Piel o escroto
- Dartos
- Capa celular subcutánea
- Fascia espermática externa
- Musculo cremáster
- Fascia espermática interna
- Túnica vaginal del testículo



Conductos espermáticos

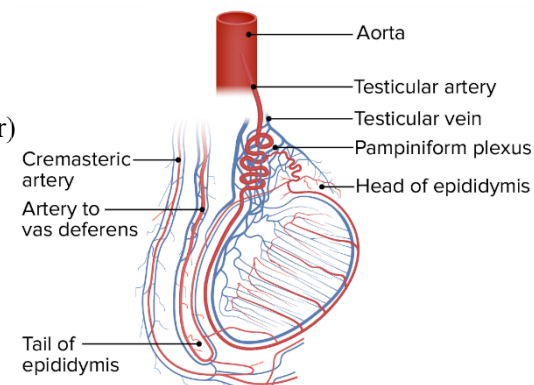
- Conductillos eferentes: Expulsan a los espermatozoides al conducto epidídimo
- Conducto del epidídimo: Maduración y almacenamiento de espermatozoides
- Conducto deferente: Involucrado en el transporte de los espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores.

Irrigación y drenaje venoso

- Arteria testicular
- Arteria cremastérica (rama de la arteria epigástrica inferior)
- Arteria del conducto deferente (rama de la arteria vesical inferior)
- Plexo pampiniforme y la vena testicular

Inervación

- Plexo testicular



FISIOLOGIA

Los testículos producen y almacenan las células germinales masculinas (espermatozoides) y secretan hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos (principalmente testosterona)



1.3. Lista de chequeo:

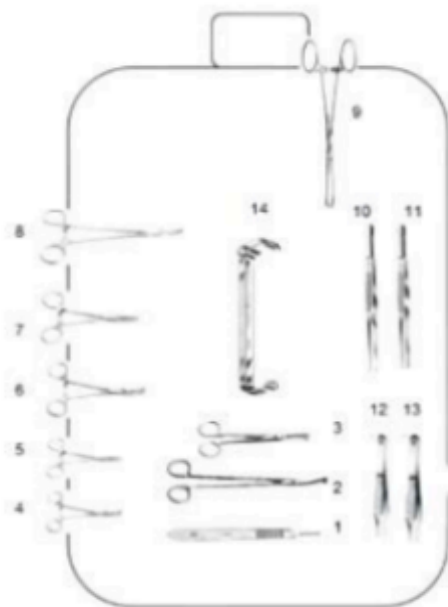
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS 😊	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta de plastia	Paquete de ropa Gasas Compresas Torundas Jeringa 10CC Aguja hipodérmica 18 y 26 Hoja de bisturí # 15 Electrobisturí Guantes	Piel: Polipropileno 2/0 o 3/0 con aguja 3/8 de circulo cortante con aguja de 27 mm. TCS: Poliglactina 910 2/0 con aguja ½ circulo tredonda de 27 mm. Fascia y musculo: Poliglactina 910 1 o 0 con aguja ½ circulo redonda de 37 mm. Conductos deferentes: Seda 3/0 con aguja ½ circulo redonda Escroto: Catgut cromado 3/0 o 4/0 con aguja ½ circulo redonda	Solución salina Lidocaína al 1% sin epinefrina



2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

Mesa de Mayo



- 65. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
- 66. Tijeras de Metzembaum
- 67. Tijeras de Mayo recta
- 68. Pinzas Kelly curva
- 69. Pinzas Kelly recta
- 70. Pinzas Kelly Adson
- 71. Pinzas Rochester curva
- 72. Pinzas Rochester recta
- 73. Pinzas Allix
- 74. Pinza de Disección Rusa
- 75. Pinza de Disección sin garra larga
- 76. Pinza de Disección con garra larga
- 77. Pinza de Disección sin garra corta
- 78. Disección Adson con garra
- 79. Separadores de Farabeuf

Mesa de Reserva



- 1. Equipo de plastia
- 2. Coca con suero
- 3. Coca
- 4. Canula de Yankawer
- 5. Porta agujas
- 6. Suturas
- 7. Pinza de campo de backhouse
- 8. Compresas
- 9. Lápiz del electro bisturí
- 10. Paquete de ropa
- 11. Guantes
- 12. Caucho de succión



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

DECUBITO SUPINO



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



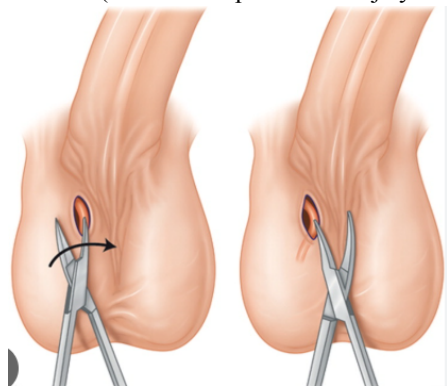


3. ETAPA DE EJECUCION:

- a) Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia regional o local.

- b) Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):



- c) Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTAL
Incisión del escroto	Mango de bisturi #3 Hoja de bisturí #15
Visualización del conducto deferente	Pinza baby mosquito curva
Toma del conducto deferente	Pinza de anillo
Selección de una pequeña porción del conducto y se cauteriza	Tijeras de plastia Electrobisturí
Se hacen puntos de transfixión en los extremos	Porta agujas de plastia Seda 3/0 con aguja ½ círculo redonda
Se repite el procedimiento en el lado opuesto	
Cierre del escroto y curación	catgut cromado 3/0 o 4/0 aguja curva redonda ½ círculo



TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA QUE UTILIZA DOS INSTRUMENTALES ESPECILES

- Con la pinza de Lee se hace la apertura de la piel
- Se toma el conducto con la pinza de anillo
- Se cauteriza el conducto deferente con el electrobisturí
- Se puede suturar el escroto o no
- Se realiza curación

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**

FIRMA ESTUDIANTE: _____

FIRMA DOCENTE: _____